รายงานการประชุม

คณะผู้วิจัยโครงการ TN-iLTC (Thailand Integrated Long-Term Care Framework)

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2569

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/บทบาทในโครงการ
1	ผศ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส	หัวหน้าโครงการ (ประธาน)
2	รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ	ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
3	ดร.รุ่งนภา คำผาง	คณะผู้วิจัย
4	พญ.ณัฐณิชา มานะบริบูรณ์	คณะผู้วิจัย (ผู้รับผิดชอบ WP1)
5	นพ.นนทกร ศิริวัฒนสาธร	คณะผู้วิจัย (ผู้รับผิดชอบ WP3) / ผู้จดรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ภาพรวมโครงการและโครงสร้าง Work Package

ประธานแจ้งว่า โครงการมีระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดประมาณ 8 เดือน แบ่งเป็น 3 Work Package (WP) ซึ่งโดยภาพรวมแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

- ส่วนที่ 1 (WP1 และ WP2) การนำมาตรฐาน WHO Global Standards for Long-Term Care มาเทียบเคียงกับบริบทของประเทศไทย ต่อด้วยการจัดลำดับความสำคัญด้วยกระบวนการ Delphi โดย WP1 และ WP2 ดำเนินการต่อเนื่องกัน
- ส่วนที่ 2 (WP3) การพัฒนาเกณฑ์การเข้าถึงบริการตามความจำเป็น (need-based eligibility criteria) และจุดเปลี่ยนผ่านของการดูแล

จากการหารือครั้งก่อน WP1 และ WP3 สามารถดำเนินการคู่ขนานกันได้ โดยแยกผู้รับผิดชอบ แต่ต้องมีจุดรอผลร่วมกันในบางขั้นตอน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ร่างแผนการดำเนินงานและการแบ่งงานช่วง 2 เดือนแรก (8 สัปดาห์)

ประธานนำเสนอร่างแผนการดำเนินงาน (TNiLTC_timeline_proposed_20260923_HP) ซึ่งเป็นร่างเบื้องต้นที่ต้องให้คณะผู้วิจัยร่วมพิจารณา โดยกำหนดให้ 2 เดือนแรกเป็นช่วงเตรียมข้อมูล และแบ่งผู้รับผิดชอบเป็น 3 คน ดังนี้

- **แพทย์คนที่ 1 (WP1):** สัปดาห์ที่ 1–2 กำหนดคำค้น ฐานข้อมูล และแบบบันทึกข้อมูล (extraction form) สัปดาห์ที่ 3–4 คัดกรองเอกสารและสกัดข้อมูลให้ตรงกับ 7 องค์ประกอบของ WHO สัปดาห์ที่ 5–6 ร่าง system mapping และ gap matrix เพื่อนำเข้าสู่ Delphi สัปดาห์ที่ 7–8 ทบทวนและสรุปผล รวมถึงรับผิดชอบการจัดประชุม ทั้งนี้ WP1 มีรายงานฉบับเดิมของหน่วย (รายงาน IMC/LTC เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน) เป็นฐาน แต่ต้องค้นเพิ่มว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- **แพทย์คนที่ 2 (WP3):** ดำเนินการเรื่อง need-based eligibility criteria ซึ่งแทบไม่มีข้อมูลเดิม ต้องสืบค้นใหม่ทั้งหมด ได้แก่ assessment domain ที่ประเทศต่าง ๆ ใช้ในการคัดเลือกผู้รับบริการเข้าสู่ระบบ LTC และจุดเปลี่ยนผ่าน (transition point) ของการดูแล คาดว่ามีปริมาณงานมากกว่า WP1 แต่มีระยะเวลาดำเนินการยาวกว่า และอาจจัดรับฟังความคิดเห็น (public hearing) ในช่วงเดือนที่ 6–7
- **แพทย์คนที่ 3 (ผู้ประสานงาน):** ติดตามความก้าวหน้า ร่วมพิจารณาเมื่อความเห็นไม่ตรงกัน (ทำหน้าที่คล้ายผู้ตัดสินฉันทามติ) และตรวจสอบความเชื่อมโยงกับผู้กำหนดนโยบาย
- **รอบการประชุม:** ผู้รับผิดชอบ 3 คนประชุมร่วมกันทุก 1–2 สัปดาห์ เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค และประชุมทั้งทีม (รวม ดร.รุ่งนภา และ รศ.พญ.วราลักษณ์) ทุก 2–4 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบประเด็นที่ยังขาดและแก้ไขได้ทันเวลา

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงานในหลักการ ให้แก้ไขคอลัมน์ "แพทย์ 2 – WP2" เป็น WP3 และปรับรายละเอียดตามมติในระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รูปแบบการศึกษาของ WP3

รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ ให้ความเห็นว่า แผนโดยรวมเหมาะสม แต่ขอให้ผู้รับผิดชอบ WP3 สืบค้นก่อนว่าเคยมีผู้ทำ systematic review ในประเด็นเดียวกันหรือไม่ เนื่องจาก WP3 เป็นการหาเครื่องมือและเกณฑ์ ซึ่งเหมาะกับการทำ systematic review อย่างยิ่ง ข้อดีคือ (1) ได้ผลงานวิชาการและตีพิมพ์ได้ และ (2) มีน้ำหนักในการนำเสนอผู้กำหนดนโยบายว่าควรดำเนินการ

แนวทางใด แล้วจึงปรับให้เหมาะกับบริบทไทย อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ จึงอาจมี systematic review อยู่แล้ว

- หากยังไม่มี ควรออกแบบ WP3 เป็น systematic review ซึ่งต้องมีผู้ทบทวนอย่างน้อย 2 คน ไม่สามารถทำคนเดียวได้
- หากต้องการกำลังคนเพิ่ม สามารถหาผู้ช่วยสืบค้นหรือช่วยในกระบวนการ systematic review ได้ แต่ต้องประเมินก่อนว่ามีหลักฐานเดิมมากน้อยเพียงใดและจะต้องทำอะไรเพิ่ม
- ประธานเห็นว่า WP1 สืบค้นอย่างเดียวก็เพียงพอ เพราะครอบคลุมเฉพาะประเทศไทย ส่วน WP3 น่าจะต้องทำเป็น systematic review
- รศ.พญ.วราลักษณ์ เห็นว่าผู้รับผิดชอบ 2 คน (นพ.นนทกร และ พญ.ณัฐณิชา) เพียงพอสำหรับการทำ systematic review แต่ต้อง explore เรื่องคำศัพท์และคำค้นก่อน

มติที่ประชุม มอบหมายให้ นพ.นนทกร ศิริวัฒนสาธร กำหนดคำถามวิจัยของ WP3 และสืบค้นว่ามี systematic review ในประเด็นเดียวกันอยู่แล้วหรือไม่ หากมีให้พิจารณานำมาใช้หรือสืบค้นเพิ่มเติม หากไม่มีให้ออกแบบเป็น systematic review โดยมีผู้ทบทวนอย่างน้อย 2 คน และนำเสนอผลในการประชุมครั้งถัดไป

4.2 แนวทางการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลของ WP1

ดร.รุ่งนภา คำผาง ให้ความเห็นว่า การกำหนดคำค้นและแหล่งข้อมูลล่วงหน้าช่วยให้การสืบค้นเป็นระบบและตรวจสอบย้อนกลับได้ แม้ยังไม่ทราบว่าจะพบข้อมูลเพิ่มจากที่เคยทำไว้มากน้อยเพียงใด ผลของ WP1 จะเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับ Delphi ซึ่งจัด 2 รอบ คือ รอบแรกแบบออนไลน์ และรอบที่สองแบบ workshop เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนี้ หลังได้ผลการทบทวนวรรณกรรมควรมีการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (มีงบประมาณแล้ว) เพื่อพิจารณาว่าเกณฑ์ที่ทบทวนได้ควรนำสิ่งใดมาใช้ในประเทศไทย แล้วจึง verify ในการประชุมที่ใหญ่ขึ้น

ดร.รุ่งนภา เสนอแนวทางตามกระบวนการที่ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยใช้ คือเริ่มจากตัวชี้วัด (indicator) ดังนี้

- กางตัวชี้วัดของ WHO และระบุว่าแต่ละตัวชี้วัดต้องการข้อมูลอะไร
- ตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่
- เทียบกับรายงานฉบับเดิมและงานของที่ปรึกษา (UHC) ว่าตอบได้ครบหรือไม่ ส่วนที่ขาดจึงสืบค้นเพิ่ม
- ประเมินปริมาณงานที่เหลือ

ทั้งนี้ ข้อจำกัดของประเทศไทยคือเอกสารบางส่วนไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ ต้องขอจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรง

รศ.พญ.วราลักษณ์ เสริมว่า รายงานฉบับเดิมมีการประเมินระบบของไทยเทียบกับ WHO โดยให้ระดับสีในแต่ละข้อ (จัดทำโดยแพทย์ประจำบ้าน) ซึ่งใช้เป็นจุดตั้งต้นได้ โดยตรวจว่าเดิมใช้หลักฐานใดสนับสนุนในแต่ละข้อ และส่วนใดต้องสืบค้นเพิ่ม

มติที่ประชุม WP1 ใช้การสืบค้นอย่างเป็นระบบ (ไม่ต้องทำ systematic review) โดยเริ่มจากตัวชี้วัดของ WHO แล้วเทียบกับรายงานฉบับเดิมและงานของ UHC มอบหมายให้ พญ.ณัฐณิชา เป็นผู้ explore และนำเสนอผลในการประชุมครั้งถัดไป

4.3 คำศัพท์ในการสืบค้นและแหล่งข้อมูลต่างประเทศ

รศ.พญ.วราลักษณ์ ให้ข้อสังเกตว่า คำศัพท์ในบริบท long-term care แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และเส้นแบ่งระหว่าง intermediate care กับ long-term care ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน เช่น ออสเตรเลียใช้คำว่า subacute care สำหรับ intermediate care และใช้ care package สำหรับการเข้าสู่ LTC หากสืบค้นด้วยคำว่า long-term care เพียงคำเดียวจะตกหล่นข้อมูล โดยเฉพาะในประเทศรายได้สูง นอกจากนี้ ข้อมูลเกณฑ์จำนวนมากอยู่ในรูป white paper หรือเอกสารของภาครัฐมากกว่าบทความวิชาการ

ดร.รุ่งนภา แจ้งว่า การทบทวนข้อมูลออสเตรเลียในรอบที่แล้ว (ดำเนินการโดยคุณปูน) เน้นเรื่อง financing model จึงไม่ครอบคลุมระบบการประเมินและเกณฑ์ที่ WP3 ต้องการ

รศ.พญ.วราลักษณ์ จะชวนคุณมิมิ (คนไทยที่อยู่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย) มาช่วยแนะนำการเข้าถึงเอกสารและเกณฑ์ของออสเตรเลีย และได้ชวนเข้าร่วม Journal Club ด้วย

มติที่ประชุม ให้ผู้รับผิดชอบ explore ข้อมูลก่อน แล้วนัดหารือเรื่องคำศัพท์และคำค้นอีกครั้ง เพื่อให้การสืบค้นตรงประเด็นและไม่กว้างเกินไป

4.4 กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการของ สวรส. และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย (IRB)

ดร.รุ่งนภา สอบถามว่า สวรส. จะมี reviewer พิจารณาข้อเสนอโครงการอีกรอบหรือไม่ เนื่องจากหากได้รับความเห็นให้ปรับแนวทาง งานที่เริ่มไปแล้วอาจต้องแก้ไข จึงเสนอให้สอบถามผู้ประสานงานของ สวรส. ให้ชัดเจน ประธานแจ้งว่า สวรส. ยังไม่ได้ตอบกลับ และได้ส่งข้อความทาง LINE ถึงผู้ประสานงานแล้ว

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า โครงการนี้เป็นโครงการพิเศษ และที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำใน workshop (อ.สุวิทย์ และ อ.วิโรจน์) อาจถือเป็นการ review ไปแล้ว แต่อาจมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) เนื่องจากมีชื่ออยู่ในทีม รศ.พญ.วราลักษณ์ จะสอบถามเรื่องนี้เพิ่มเติม

เรื่อง IRB ประธานสอบถามว่าควรยื่นเป็นโครงการใหญ่ฉบับเดียว หรือแยกโครงการย่อย ดร.รุ่งนภา เห็นว่ายื่นฉบับเดียวได้ โดยระบุว่าโครงการประกอบด้วยงานกี่ส่วน แต่ละส่วนตอบวัตถุประสงค์ใด และมีวิธีการอย่างไร ส่วนงานทบทวนเอกสารสามารถเริ่มได้โดยไม่ต้องรอ IRB อนุมัติ และดำเนินการคู่ขนานไปได้ ส่วนการจัดประชุมให้ดำเนินการหลังได้รับอนุมัติ

มติที่ประชุม (1) ประธานติดตามคำตอบจากผู้ประสานงาน สวรส. เรื่องกระบวนการ review (2) รศ. พญ.วราลักษณ์ สอบถามประเด็น COI (3) ยื่น IRB ฉบับเดียวครอบคลุม WP1–3 และเริ่มงานทบทวนเอกสารได้ทันที

4.5 การแบ่งผู้รับผิดชอบและกรอบเวลา

รศ.พญ.วราลักษณ์ ให้ข้อสังเกตว่า พญ.ณัฐณิชา มีภาระงานการฝึกอบรมในช่วงท้ายของโครงการ โครงการจึงต้องเสร็จภายใน 8 เดือนตามกรอบเวลา และงานในช่วงนั้นควรเหลือเพียงงานเขียนรายงาน หากต้องการผู้ช่วยสามารถหาเพิ่มได้ นอกจากนี้ จากประสบการณ์โครงการก่อนหน้า หากไม่แบ่งงานชัดเจนจะเกิดช่องว่างที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบเขียน job description ของตนให้ชัดเจน

ดร.รุ่งนภา เห็นด้วยว่าต้องแบ่งผู้รับผิดชอบตามหัวข้อหลัก และในช่วง explore สามารถรับผิดชอบคนละหัวข้อได้ เมื่อถึงขั้นทำ systematic review จริงจึงให้อีกคนช่วยในการสืบค้นและคัดกรอง

มติที่ประชุม นพ.นนทกร รับผิดชอบ WP3 และ พญ.ณัฐณิชา รับผิดชอบ WP1 ในช่วง explore ให้ทั้งสองคนเขียน job description และนำเสนอผลการ explore ในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ที่ประชุมกำหนดนัดภายใน 2 สัปดาห์ (ช่วงวันที่ 5–9 ตุลาคม 2569) รศ.พญ.วราลักษณ์ อาจต้องเดินทางในช่วงบ่าย จึงกำหนดช่วงเช้า

มติที่ประชุม กำหนดประชุมครั้งถัดไป วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 10.00–12.00 น.

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

(ลงชื่อ) .....

(นพ.นนทกร ศิริวัฒนสาธร)

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) .....

(ผศ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปงานที่ได้รับมอบหมาย

ที่	ผู้รับผิดชอบ	งาน	กำหนดส่ง
1	ผศ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส	ติดตามคำตอบจากผู้ประสานงาน สวรส. เรื่อง กระบวนการ review ข้อเสนอโครงการ	ก่อน 8 ต.ค. 2569
2	รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ	สอบถาม สวรส. เรื่อง COI ของที่ปรึกษาที่มีชื่อในทีม	ก่อน 8 ต.ค. 2569
3	ผศ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส	จัดเตรียม IRB ฉบับเดียวครอบคลุม WP1–3	ดำเนินการต่อเนื่อง
4	พญ.ณัฐณิชา	Explore WP1: กางตัวชี้วัด WHO เทียบกับรายงานฉบับเดิมและงานของ USC ระบุข้อมูลที่ต้องสืบค้นเพิ่ม	8 ต.ค. 2569
5	นพ.นนทกร ศิริวัฒนสาธร	Explore WP3: กำหนดคำถามวิจัย และสืบค้น systematic review ที่มีอยู่เดิม	8 ต.ค. 2569
6	นพ.นนทกร, พญ.ณัฐณิชา	เขียน job description ของแต่ละคน	8 ต.ค. 2569
7	รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ	ชวนคุณมิมิช่วยแนะนำแหล่งข้อมูลเกณฑ์ของออสเตรเลีย	รอยืนยัน
8	คณะผู้วิจัย	หารือและตกลงคำศัพท์/คำค้นร่วมกัน	ประชุม 8 ต.ค. 2569